

Série Hémorragies digestives FMSf 2025

Pr Ag Zouari Amine

Pré-test

1) L'étiologie d'une HD peut être un/une :

- A- Cancer de L'estomac
- B- Cholangiocarcinome
- C- Adénocarcinome de l'intestin grêle
- D- Traumatisme pancréatique
- E- Cancer du cavum

2) L'hémorragie digestive haute est définie par :

- A- L'extériorisation de sang par la bouche.
- B- Une hémorragie par une lésion du TD située en amont de la papille
- C- Une hémorragie par une lésion du TD située en amont de l'angle duodéno-jéjunal
- D- Une hémorragie qui survient en aval de l'intestin grêle
- E- Une hémorragie qui survient en amont du colon

3) Le tronc cœliaque :

- A- Vascularise une partie du foie
- B- Vascularise avec l'artère mésentérique supérieur la totalité de l'estomac
- C- Donne naissance à 3 branches artérielles
- D- Naît de l'aorte abdominale en regard du bord inférieur de T12
- E- A une longueur de 1 à 3 cm

4) L'artère hépatique commune :

- A- Participe à la vascularisation de l'estomac
- B- Donne naissance à l'artère gastro-duodénale
- C- Vascularise exclusivement le foie
- D- Est une branche terminale du tronc cœliaque
- E- Donne 2 branches formant l'arcade pancréatico-duodénale postérieure

5) L'artère splénique :

- A- Est la branche la plus volumineuse du TC
- B- Se chemine de droite à gauche, selon un trajet sinueux ,en sous pancréatique
- C- Participe à la vascularisation de l'estomac
- D- Participe à la vascularisation du bas œsophage
- E- Donne une branche destinée pour l'angle colique gauche

6) Les anastomoses "shunts" porto-caves :

- A- Sont des conséquences de l'HTP
- B- Peuvent prendre un grand développement à la suite d'une thrombose des 2 veines iliaques primitives
- C- Peuvent être secondaires à une reperméabilisation de l'anastomose porto-sus-hépatique
- D- Peuvent être secondaire à des anastomoses pariéto-pariétales de la paroi abdominale
- E- Peuvent se déclarer par une HD secondaire à une poussée d'hémorroïdes ou à des varices œsophagiennes

7) Les facteurs favorisant la survenue de l'HDH « ulcéreuse » sont :

- A- Prise des antiagrégants plaquettaires
- B- La prise d'anti-inflammatoires stéroïdiens
- C- La consommation d'alcool
- D- La prise de neuroleptique
- E- Le tabagisme

Le tabac est un facteur de retard de cicatrisation de l'ulcère et non pas de survenue d'une hémorragie

8) À propos les localisations à risque plus marqué d'hémorragie de grande abondance :

- A- **Ulcère de la face postérieure du bulbe duodénal par érosion de l'artère gastro duodénale**
- B- Ulcère du bord supérieur du bulbe duodénal par érosion de l'artère gastro-épiploïque droite.
- C- **Ulcère de la petite courbure gastrique par érosion de l'artère gastrique gauche**
- D- Ulcère pré cardinal
- E- Ulcère cardio tubérositaire

9) L'encéphalopathie hépatique est :

- A- Un trouble irréversible du système nerveux central
- B- **Lié à une insuffisance hépatique de la dégradation des neurotoxines libérées par l'intestin**
- C- **Due à l'accumulation de l'ammoniac dans le sang**
- D- Prévenue par la prescription de ralentisseur de transit
- E- Prévenue par la prescription d'octréotides et de leurs dérivés

10) Devant un rejet de sang par la bouche, on retient en faveur de l'hématémèse :

- A- L'abondance du saignement
- B- Le rejet du sang rouge aéré
- C- **Sa survenue au cours d'effort de vomissement**
- D- Son goût salé
- E- **Le rejet de sang mêlé de débris alimentaires**

11) Le Méléna :

- A- Correspond à l'émission par l'anus de sang non digéré sous forme de selles noirâtres fétides
- B- Correspond à une HD basse dans 80% des cas
- C- **Doit être différenciée des selles noirâtres dues à la prise d'un traitement martial**
- D- Est une CDD des cancers du côlon et du rectum
- E- **Est une CDD des cancers de l'estomac**

Cas clinique :

Un patient de 45 ans, ayant des antécédents d'hypertension artérielle (HTA) et de douleurs épigastriques de type ulcéreux évoluant depuis plusieurs mois, consulte pour une hématomèse.

12) L'examen clinique met en évidence plusieurs signes, parmi lesquels certains sont des signes de gravité, à savoir :

- A- Une tachycardie à 120 battements / min
- B- Une agitation avec trouble neurologique
- C- Glossite atrophique (langue lisse et douloureuse)
- D- Une TA à 95/50 mmHg
- E- De sang émis par la bouche, évalué à 1 litre selon les témoignages des membres de sa famille

13) La conduite à tenir initiale est la :

- A- Mise en place de 2 voies veineuses périphériques et d'une voie veineuse centrale.
- B- Surveillance continue par Scope
- C- Réalisation d'une numération de la formule sanguine
- D- Réalisation du groupe sanguin et du bilan d'hémostase (TP, TCK, INR, Plaquettes)
- E- Orientation rapidement du patient vers le bloc opératoire compte tenu de l'instabilité hémodynamique

La perte sanguine a été évaluée à 30% (Classe III), et l'hémoglobine était à 6 g/dl, et les plaquettes étaient à 110 000/mm³.

Les autres examens demandés étaient normaux, à l'exception d'un allongement de l'intervalle QT à l'ECG.

14) Pour lutter contre les éléments de l'état de choc et assurer un remplissage vasculaire initial, nous procédons à :

- A- La mise en place systématique d'un cathéter veineux central jugulaire
- B- La perfusion immédiate de solutés colloïdes
- C- La transfusion de 2 culots globulaires
- D- La transfusion de plaquettes
- E- L'administration de drogues vasoactives

15) L'évaluation de l'efficacité de la prise en charge initiale se fait sur :

- A- La palpation abdominale
- B- La diurèse horaire
- C- La mesure de la pression artérielle
- D- L'absence de récurrence de l'hématomèse
- E- La fréquence cardiaque

Le patient a été stabilisé après 30 minutes de réanimation.

À la poursuite de l'interrogatoire, il signale une consommation chronique d'alcool.

L'inspection de l'abdomen met en évidence une circulation veineuse collatérale.

16) Les autres éléments de prise en charge sont :

- A- Administration d'IPP à forte dose et en continu
- B- Administration d'érythromycine 250 mg en IV 60 minutes avant l'endoscopie
- C- Lavage gastrique avec sérum glacé
- D- Administration de Sandostatine à la seringue électrique
- E- Réalisation d'une FOGD (Fibroscopie CEs-Gastro-Duodénale) au bloc opératoire

La FOGD montre la présence d'un ulcère du bulbe duodénal, et elle a classé l'ulcère Forrest IIa

17) À propos de cet ulcère :

- A- C'est un type à fort risque de récurrence hémorragique
- B- La coagulation thermique n'est pas le traitement de choix
- C- Le traitement de *H. pylori* dès la reprise de l'alimentation orale permet de réduire la récurrence ulcéreuse
- D- Il n'y a pas d'indication d'IPP en continu devant ce type d'ulcère
- E- L'alimentation est permise tout de suite.

18) Un traitement chirurgical de cette hémorragie ulcéreuse est indiqué si, au cours de la surveillance, on retrouve :

- A- Une récurrence hémorragique massive cataclysmique
- B- Une récurrence hémorragique après 2 tentatives d'hémostase endoscopique
- C- Une déglobulisation de 2 g/dL à la NFS de contrôle
- D- Une thrombopénie à $90\,000/\text{mm}^3$ à la NFS de contrôle
- E- Impossibilité du traitement endoscopique en cas de saignement actif artériel

19) Le patient a été opéré en urgence et a bénéficié d'une intervention de Weinberg. Ce type d'intervention :

- A- Est indiquée pour les ulcères gastriques ou duodénaux hémorragiques
- B- Nécessite la pratique d'une incision antro-pyloro-duodénale
- C- A pour but de faire l'hémostase directe de l'ulcère hémorragique par suture chirurgicale
- D- Comporte la réalisation d'une bi-vagotomie tronculaire pour traiter la pathologie ulcéreuse
- E- Nécessite la pratique d'une pyloroplastie pour réduire le risque de récurrence ulcéreuse

20) Avant de porter l'indication opératoire, l'équipe médicale a discuté la possibilité d'une artériographie avec embolisation.

Ce type de traitement :

- A- Est une méthode thérapeutique de la pathologie ulcéreuse
- B- Elle est essentiellement indiquée en cas de contre-indication à un geste d'hémostase chirurgicale, notamment chez les patients âgés et présentant des comorbidités
- C- Est très prometteur, en particulier chez les patients instables à haut risque chirurgical
- D- Nécessite l'injection d'un produit radio-opaque
- E- Nécessite la mise en place d'un stent

Série :

21) L'artère gastrique gauche :

- A- Participe à la vascularisation de la rate
- B- Vascularise une partie de l'œsophage
- C- Vascularise dans 70% des cas le foie gauche
- D- À une longueur de 4 à 7 cm
- E- Donne 2 branches formant l'arcade artérielle de la petite courbure

22) L'artère Gastroduodénale :

- A- Vascularise la petite courbure
- B- Se chemine en retro Duodénale (D1)
- C- Donne l'artère Pancréatico-duodénale supéro-antérieure
- D- Participe à la vascularisation de la grande courbure gastrique
- E- Est une branche de l'hépatique commune

23) Le tronc de la veine porte :

- A- Mesure en moyenne 20 cm de longueur
- B- Se divise en deux branches, droite et gauche en rétro-pylorique
- C- Il se dirige obliquement en haut et à droite dans la pars vasculosa du petit omentum
- D- Résulte de l'union de la veine splénique et les 2 veines mésentériques
- E- Reçoit comme collatérales : les 2 veine gastriques (gauche et droite) et la veine pancréatico-duodénale supéro-postérieure

24) Les facteurs favorisant la survenue de l'HDH sont :

- A- Prise de médicament à base de kétoprofène
- B- Prise d'Aspégic à dose de 100mg/jour
- C- Période de stress post traumatique (AVP)
- D- La prise de médicament à base d'Esoméprazole
- E- La corticothérapie

25) En cas d'ulcères hémorragiques de la face postérieure du bulbe duodéal, le vaisseau le plus souvent responsable du saignement est :

- A- Artère pylorique
- B- Artère splénique
- C- Artère gastroduodénale
- D- Artère gastro-épiploïque droite
- E- Artère pancréatico-duodénale inférieure

26) Les facteurs favorisant de l'HD secondaires à une rupture des varices œso-gastrique sont :

- A- La mise en place d'une sonde naso-gastrique
- B- La prise d'AINS
- C- La prise de médicaments anti cholinergiques
- D- La décompensation de la cirrhose
- E- Le tabagisme

27) Parmi les affections suivantes lesquelles peuvent être révélées par un méléna :

- A- Ulcération de Dieulafoy
- B- Tumeur sigmoïdienne
- C- Diverticule de Meckel
- D- Polype rectal
- E- Tumeur caecale

28) L'abondance de l'hémorragie :

- A- est sous-estimée par le patient
- B- Est jugée sur le nombre de CG reçus**
- C- Peut être évalué par des critères cliniques et biologiques**
- D- Est bien quantifiée par la pose d'une sonde gastrique
- E- Est jugée de faible abondance si l'hémoglobine pratiquée en urgence est normale

29) La gravité d'une hémorragie digestive :

- A- S'apprécie surtout par la quantité de sang extériorisé
- B- S'apprécie par le retentissement hémodynamique**
- C- S'apprécie par le rythme et la quantité d'unité de sang transfusé**
- D- Est indépendante de l'étiologie
- E- Est indépendante de l'état antérieur du malade

30) La prédiction de la gravité d'une HDH est basée sur :

- A- La profondeur de l'anémie hypochrome microcytaire
- B- Pouls rapide et filant**
- C- La quantité de sang extériorisée
- D- Hématocrite basse**
- E- La quantité de sang ramenée par la sonde gastrique

31) Quel élément permet le mieux d'apprécier l'abondance de l'hémorragie en présence d'une hématomèse grave ? :

- A- La quantité de sang rejetée
- B- La quantité de sang nécessaire pour rétablir et maintenir une tension correcte**
- C- L'agitation du patient
- D- La fréquence respiratoire
- E- La pâleur

32) L'enquête étiologique devant une HD :

- A- Doit être réalisée en premier lieu, pour démarrer et orienter la prise en charge thérapeutique
- B- Est l'association des éléments de l'interrogatoire et de l'examen physique
- C- Doit chercher les signes de HTP, notamment l'ascite, la CVC et la splénomégalie**
- D- Doit préciser la notion de prise de médicament gastro-agressifs**
- E- Élimine l'origine haut si pas d'hématomèse avec lavage gastrique négatif

33) Devant une hémorragie digestive :

- A- L'hématomèse signe l'origine haut de l'hémorragie**
- B- Le méléna oriente vers un saignement au aval de l'angle DJ
- C- Le saignement à partir du duodénum est une HDB
- D- La présence d'un méléna oriente vers la pratique d'une endoscopie haute**
- E- La présence de rectorragie oriente vers la pratique d'une endoscopie basse

34) Devant un méléna isolé, quelle exploration demandez-vous de première intention ?

- A- Coloscopie
- B- Transit du grêle
- C- Fibroscopie OGD**
- D- Artériographie
- E- Angioscanner

35) Les 3 causes les plus fréquentes des HDH sont :

- A- Ulcère duodénal ou gastrique
- B- Cancer gastrique
- C- Lésions aiguës gastroduodénales
- D- Syndrome de Mallory Weiss
- E- Rupture des varices œso-gastriques

36) Le taux de récurrence de l'HDH par UGD est nettement augmenté devant :

- A- Âge jeune
- B- La taille de l'ulcère
- C- Siège sur la face antérieure du bulbe duodénal
- D- Siège sur la petite courbure gastrique
- E- Les types I et II selon la classification de Forrest

37) Les lésions aiguës gastroduodénales :

- A- Peuvent être secondaires à un traitement à faible dose d'AINS
- B- Peuvent être secondaires à un polytraumatisme
- C- De stress sont induites dans la plupart des cas chez les patients avec ATCD de psychose
- D- Peuvent être secondaires à une corticothérapie
- E- Ont un risque qui peut être majoré par un traitement par les AVK

38) L'hypertension portale :

- A- Est définie par une augmentation du gradient de pression porto-cave au-delà de 10 mm Hg
- B- A un risque d'hémorragie digestive si le gradient dépasse 12 mmHg
- C- Est le plus souvent secondaire à une cirrhose hépatique
- D- Se complique d'HDH par RVOG dans 40% des cas
- E- Peut se compliquer d'HDH secondaire à un UG ou D dans 30% des cas

39) L'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes (VO) ou gastrique :

- A- Est le plus souvent une hémorragie massive compliquée d'une instabilité de l'état hémodynamique
- B- Avec absence de tachycardie suggère un tableau moins grave
- C- Est associée à une mortalité élevée de 10 à 20 % à 6 semaines
- D- Est la cause la plus fréquente d'HDH
- E- Peut être suspectée par des éléments cliniques et paracliniques

40) Les causes rares d'HDH sont :

- A- Le syndrome de Turner
- B- RCH
- C- Le syndrome de Mallory-Weiss
- D- Les Wirsungorragies et les hémobilies
- E- L'ulcération de Dieulafoy

41) À propos des étiologies des hémorragies digestives basses :

- A- Les 2 étiologies les plus fréquentes chez l'adulte sont les CCR et les MICI
- B- Les 2 pathologies les plus incriminées dans l'hémorragie de grande abondance sont les angiodysplasies et la maladie diverticulaire
- C- La cause la plus fréquente chez l'enfant est la maladie de Hirschsprung
- D- La fissure anale peut se compliquer de Rectorragie
- E- La prise d'alcool favorise le saignement d'origine diverticulaire

42) Patient âgé de 50 ans , consulte pour une poussée hémorroïdaire avec rectorragies sans retentissement sur l'état hémodynamique :

- A- Le premier diagnostic à évoquer est la diverticulose colique gauche.
- B- Aucune exploration n'est indispensable si le diagnostic de maladie hémorroïdaire est posé
- C- Il faut éliminer d'emblée une lésion œso-gastro-duodénale
- D- La recto-sigmoïdoscopie est l'examen de première intention
- E- L'artériographie coelio-mésentérique est indiquée en cas de persistance du saignement malgré une endoscopie étiologique négative.

43) Les Angiodysplasies coliques et grêliques :

- A- Sont des anomalies vasculaires dégénératives
- B- Plus fréquentes chez le sujet jeune
- C- Sont plus fréquentes au niveau du colon gauche
- D- Sont souvent associées à une insuffisance rénale
- E- Sont souvent associées à une valvulopathie aortique

44) La réanimation d'un EDC hémorragique comporte :

- A- Le remplissage utilisant les colloïdes de premier intention
- B- Le recours aux drogues vasoactifs si hypotension persistante > 30 min (Noradrénaline)
- C- La transfusions si Hb < 10
- D- Le remplissage utilisant 2 voies centraux si EDC
- E- L'administration de PPSB si surdosage d'AVK

45) La CAT initiale devant un malade ayant une HDH avec EDC comporte :

- A- Le remplissage vasculaire
- B- L'administration de Sandostatine
- C- Un bilan biologique associant un GS, une NFS et un TP
- D- Mise en place d'une sonde vésicale
- E- Mise en place d'une sonde naso gastrique pour quantifier et surveiller le saignement

46) La réalisation de la FOGD pour HD est :

- A- Indiquée de première intention si hématémèse
- B- Indiquée de première intention si méléna
- C- Faite en urgence dans un délai ne dépassant pas les 6h
- D- Faite après préparation par lavage gastrique ou par l'administration de l'Érythromycine
- E- Pratiquée au bloc opératoire avec présence d'un chirurgien

47) L'hémostase endoscopique pour l'HDH est :

- A- Réalisée pour les stades I et II de Forrest
- B- Efficace dans 70% des cas
- C- Faite par la vaporisation d'adrénaline 1/10 ou de poudre hémostatique ou par la pose de clips
- D- Recommandée en utilisant la coagulation thermique par bistouri électrique
- E- Plus efficace en utilisant deux techniques endoscopiques

48) Devant un ulcère duodénal hémorragique, l'indication d'un traitement chirurgical doit être posée dans un (plusieurs) de(s) cas suivant(s) :

- A- Un saignement actif
- B- Un collapsus mal contrôlé par le traitement médical
- C- Une hémorragie révélatrice de la maladie ulcéreuse
- D- Une récurrence de l'hémorragie au cours du traitement médical
- E- Une sténose pyloro-bulbaire associée

49) L'intervention de Weinberg comporte :

- A- Vagotomie tronculaire isolée
- B- Ligature de l'artère gastro-duodénale
- C- Suture simple de l'ulcère
- D- Gastrectomie 2/3
- E- Hémostase endo-ulcéreuse + vagotomie + pyloroplastie

50) Le traitement chirurgical de l'Ulcère gastrique hémorragique :

- A- Nécessite une pyloroplastie associée à l'hémostase chirurgicale
- B- Se fait généralement par une résection atypique
- C- Peut être fait par geste d'hémostase directe
- D- Comporte la réalisation d'une bi-vagotomie tronculaire pour traiter la pathologie ulcéreuse associé à un geste de vidange gastrique
- E- Nécessite la pratique d'une FOGD de contrôle si hémostase par suture

51) Le remplissage au cours d'une HD par RVO :

- A- Doit être rapide utilisant les colloïdes en 1^{er} intention
- B- Se fait au mieux par VIV périphérique, la voie centrale est déconseillée
- C- A pour objectif une PAM de 80 mmHg
- D- A pour objectif une TAS >12
- E- Doit être ajusté selon les éléments de surveillance clinique notamment la diurèse

52) Le conditionnement d'un patient présentant une HD par RVO comprend :

- A- La surveillance de la pression intra vésicale
- B- Une oxygénation par masque à haute concentration
- C- La mise en place systématique d'une SNG qui sera utile pour faire le vidange gastrique avant la réalisation de la FOGD
- D- La pose 1 ou 2 VIV périphériques (calibre ≥ 14 G)
- E- La mise en place de la sonde de Blakemore dans l'attente de la réalisation de la FOGD si saignement abondant persistant

53) Le traitement médical de l'HD par RVO comprend :

- A- Une antibiothérapie que si l'enquête infectieuse est positive
- B- Des médicaments vasoactifs qui doivent être administrés précocement
- C- L'albumine pour prévenir l'encéphalopathie
- D- Des laxatifs intestinaux
- E- Des IPP à la pousse seringue

54) L'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes :

- A- Impose l'administration de médicaments vaso-actifs avant même la réalisation de la fibroscopie digestive haute.
- B- Impose un remplissage vasculaire par des cristalloïdes tenant compte de la PA moyenne.
- C- Est traitée de première intention par tamponnement des varices.
- D- Impose la prévention de l'infection du liquide d'ascite
- E- Nécessite un traitement chirurgical d'emble.

55) Le traitement de première intention de l'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes chez un cirrhotique est :

- A- TIPS
- B- La transection œsophagienne
- C- L'anastomose porto systémique
- D- La ligature élastique des varices œsophagiennes
- E- La transplantation hépatique

56) Le traitement endoscopique de l'HD par RVOG comprend :

- A- L'utilisation des clips
- B- L'électrocoagulation
- C- La ligature élastique qui est la méthode de référence pour VO
- D- La sclérothérapie avec efficacité à 85-90%
- E- L'injection de colle biologique surtout utilisé pour les varice du bas œsophage

57) L'anastomose porto-cave par voie trans jugulaire TIPS est :

- A- Un shunt prothétique intra hépatique
- B- Indiquée seulement en cas d'HDH réfractaire au traitement médical et endoscopique
- C- Indiquée devant l'échec de la prévention secondaire des VOG
- D- Contre indiquée en cas d'insuffisance cardiaque ou HTAP sévère
- E- Plus efficace si utilisation de matériel prothétique non couvert

58) Le traitement chirurgical de L'HD par RVO-G:

- A- Est actuellement le traitement de référence après échec de l'hémostase endoscopique
- B- Est préconisé pour des centres experts
- C- Est basé sur la confection d'une anastomose porto cave trans hépatique
- D- Est indiqué devant l'échec du tamponnement local par la sonde de Blakemore
- E- Est indiqué en 1^{ère} intention si Child C

59) La prévention de la récurrence hémorragique par rupture de varices œsophagiennes peut être faite par :

- A- Sclérose endoscopique
- B- Ligature élastique
- C- Sandostatine au long cours
- D- Bêtabloquants non cardiosélectifs
- E- TIPS

60) La récurrence de l'HDH par RVO :

- A- Est fréquente et précoce
- B- Surviennent dans les 10 jours qui suivent l'épisode hémorragique dans 30% des cas
- C- Est mortelle dans 70% des cas si précoce
- D- Peut être prévenue par les b-bloquant non cardio sélectif
- E- Peut être prévenue par la ligature élastique endoscopique

61) La prévention secondaire d'une récurrence de l'HDH par RVO :

- A- Repose sur un traitement qui associe b-bloquant non cardio sélectif et ligature des VO
- B- Se fait par l'administration de b-bloquant non cardio sélectif en association avec le traitement vasoactif
- C- La présence d'hyponatrémie <130 mmol/l ou une PAS < 90mmhg ou une IRA, nous oblige de diminuer la posologie, voire de suspendre le traitement par b-bloquant
- D- Peut être basée sur l'utilisation d'une Anastomose Porto-Cave après échec des autres moyens
- E- Repose sur la mise en place d'un TIPS

62) La récurrence hémorragique de la maladie ulcéreuse :

- A- Surviennent dans plus de 90% des cas dans les 3 - 4 premiers jours
- B- Peut être prévenue en utilisant un traitement vaso-actif
- C- Peut être prévenue par l'utilisation d'IPP simple dose au long cours en cas d'un traitement à base d'AINS maintenu pour un patient avec d'autres facteurs de risque
- D- D'un ulcère du bulbe duodénale, peut être prévenue par l'éradication systématique d'HP
- E- D'un ulcère gastrique, doit être prévenue par la prescription d'un IPP au long cours à simple dose

63) La prévention d'une HD en situations de stress « malade en réanimation » est basée sur :

- A- L'utilisation d'IPP dès le 5^{ème} jour d'hospitalisation
- B- L'utilisation d'un traitement vaso-actif
- C- Le sucralfate à la dose de 4 à 6 g/j
- D- La réintroduction de la nutrition entérale précocement
- E- La contre-indication de l'utilisation de l'héparine de bas poids moléculaire

Post-test

64) Les autres éléments de prise en charge sont :

- A- Administration d'IPP à forte dose et en continu
- B- Administration d'érythromycine 250 mg en IV 60 minutes avant l'endoscopie
- C- Lavage gastrique avec sérum glacé
- D- Administration de Sandostatine à la seringue électrique
- E- Réalisation d'une FOGD (Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale) au bloc opératoire

65) L'HD secondaire a un saignement de l'intestin grêle :

- A- Est une HDH
- B- Est une HDB
- C- Chez l'adulte jeune, il faut évoquer le diverticule de Meckel
- D- Donne toujours du méléna
- E- Est exceptionnelle

66) Les lésions à l'origine d'une hémorragie digestive haute peuvent intéresser :

- A- N'importe quel segment du tractus digestif
- B- Le segment digestif entre la bouche de Killian et l'angle duodéno-jéjunale
- C- La partie du tractus digestif en amont de la valvule iléo-caecale
- D- Le conduit œsophagien
- E- Le sphincter d'Oddi

67) L'artère hépatique propre :

- A- Donne l'artère gastrique droite
- B- Se chemine en rétro porte
- C- Donne l'artère Pancréatico- duodénale supéro-antérieure
- D- Vascularise la vésicule biliaire par l'intermédiaire de l'artère cystique
- E- Est une branche de l'hépatique commune

68) Une hémorragie digestive haute de faible abondance peut se révéler par un (une) :

- A- Hématémèse
- B- Anémie chronique
- C- État de choc hémorragique
- D- Méléna
- E- Rectorragie

69) Les hémorragies digestives basses :

- A- Proviennent d'un saignement en aval du pylore
- B- Sont toujours extériorisées par des rectorragies
- C- Sont toujours extériorisées par des méléna
- D- Sont souvent d'origine grêlique
- E- Peuvent conduire à une colectomie subtotale en urgence

70) Les éléments de gravités de l'HD sont :

- A- La récurrence
- B- La survenue chez un patient jeune
- C- La survenue chez un patient sous corticothérapie
- D- La survenue chez un patient sous anti vit K
- E- Le saignement en nappe

71) L' (les) élément (s) clinico- biologique (s) en faveur d'une hématomérose de grande abondance chez un patient non cirrhotique est (sont) :

- A- L'association à des mélénes
- B- Pouls rapide et filent
- C- Pression systolique < 90 mmHg
- D- Hématocrite à 35 %
- E- TP à 30%

72) L'hémorragie secondaire à un ulcère duodénal ou gastrique :

- A- Représente l'étiologie la plus fréquente d'HDH (90% des cas)
- B- Est la complication la plus fréquente de la pathologie ulcéreuse
- C- Est classée par l'endoscopie haute selon la classification de FORREST
- D- Peut se révéler par une rectorragie chronique
- E- Peut se révéler par une anémie ferriprive

73) Le risque d'HDH chez les patient sous AINS :

- A- Est multiplié par un facteur de 2
- B- Est augmenté chez les patients âgés
- C- Est augmenté par l'alcoolisme chronique
- D- Est augmenté par l'association avec la corticothérapie
- E- Est nettement diminué de 70% par l'utilisation d'AINS sélectifs

74) L' (les) argument (s) en faveur d'une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes est (sont) :

- A- Instabilité de l'état hémodynamique malgré la réanimation intense
- B- Association hématomérose- rectorragie
- C- Antécédents d'hépatite
- D- Absence de signes biologiques d'insuffisance hépatocellulaire
- E- Hépatomégalie à bord inférieur tranchant avec splénomégalie

Cas clinique :

Monsieur S,M, âgé de 58 ans, connu porteur de cirrhose hépatique.

Il a été admis aux urgences en raison de vomissements de sang et de selles noires goudronneuses.

Il se plaint de faiblesse, de fatigue et présente des signes de confusion.

À l'examen, le patient présente un teint pâle, une fréquence respiratoire de 22 c/min, une tension artérielle de 9,5/5,5 mmHg, et une saturation en oxygène de 96%. Il montre des signes de déshydratation.

L'examen abdominal révèle une hépatomégalie avec splénomégalie.

Une matité déclive à la percussion et le toucher rectal montre la présence de selles noires.

Les résultats de la biologie montrent une hémoglobine à 6 g/dl et un temps de prothrombine à 40%

75) Ce tableau clinique montre :

- A- Un tableau d'Hémorragie Digestive Haute (HDH)
- B- La présence de rectorragie
- C- Un trouble de la coagulation
- D- Des signes d'HTP (Hypertension Portale)
- E- Des signes d'encéphalopathie

76) Le conditionnement de ce patient comprend :

- A- La pose d'un cathéter artériel
- B- La pose d'une sonde vésicale**
- C- La mise en place d'une sonde nasogastrique (SNG)
- D- La pose d'une voie veineuse jugulaire (calibre ≥ 14 G),**
- E- La mise en place de la sonde de Blakemore en attendant la réalisation de la gastroscopie (FOGD)

77) La conduite initiale devant ce tableau nécessite :

- A- La prescription de laxatif intestinal**
- B- Une antibiothérapie à base de fluoroquinolone**
- C- L'injection d'IPP à la pousse-seringue**
- D- La perfusion d'albumine**
- E- L'administration de bêta-bloquant

Une FOGD d'urgence est réalisée, montrant des varices œsophagiennes saignantes.

78) Le traitement que vous indiquez devant cette hémorragie digestive chez ce patient comporte :

- A- Une TIPS
- B- La transsection œsophagienne
- C- La pratique d'une anastomose porto-systémique
- D- La ligature élastique des varices œsophagiennes**
- E- La transplantation hépatique

79) La prévention de la récurrence hémorragique chez ce patient nécessite :

- A- Une sclérothérapie endoscopique
- B- Des séances de ligature élastique si varices grade 2-3**
- C- L'utilisation de la Sandostatine à long terme
- D- Un bêta-bloquant non cardiosélectif**
- E- La pratique de la TIPS

L'évolution a été marquée par une récurrence hémorragique sans défaillance hémodynamique, avec une hémoglobine à 5 g/dl au 3^{ème} jour d'hospitalisation :

80) Choisir la(les) bonne(s) réponse(s) :

- A- Le patient a un risque de décès à 40 %**
- B- C'est une indication à un traitement endoscopique**
- C- C'est Une indication à un traitement chirurgical, notamment une anastomose porto-systémique
- D- Il faut envisager une transfusion sanguine pour atteindre une hémoglobinémie supérieure à 10 g/dl
- E- C'est une indication à L'injection de bêtabloquants par voie intraveineuse